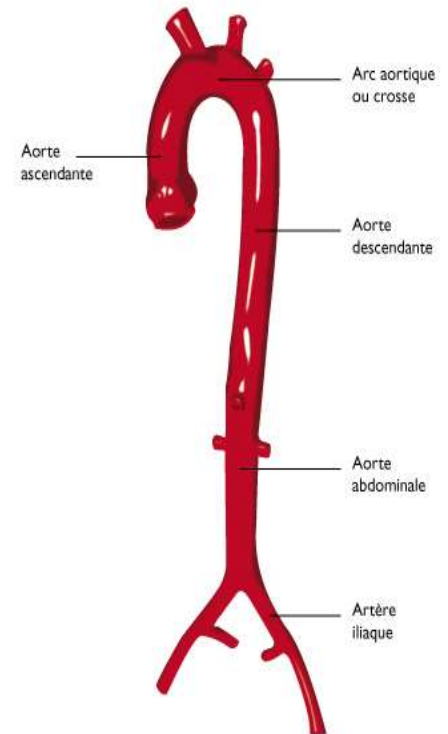


Pathologie de l'aorte

Dr KELLIL Fardous

Maitre assistante

CHU Constantine



Introduction

A). Pathologies congénitales

B). Pathologies acquises

1. Anévrisme de l'aorte
2. Syndromes aortiques aigus
3. pathologies inflammatoires et infectieuses
4. Pathologies valvulaires et de la racine aortique

Anévrisme de l'aorte

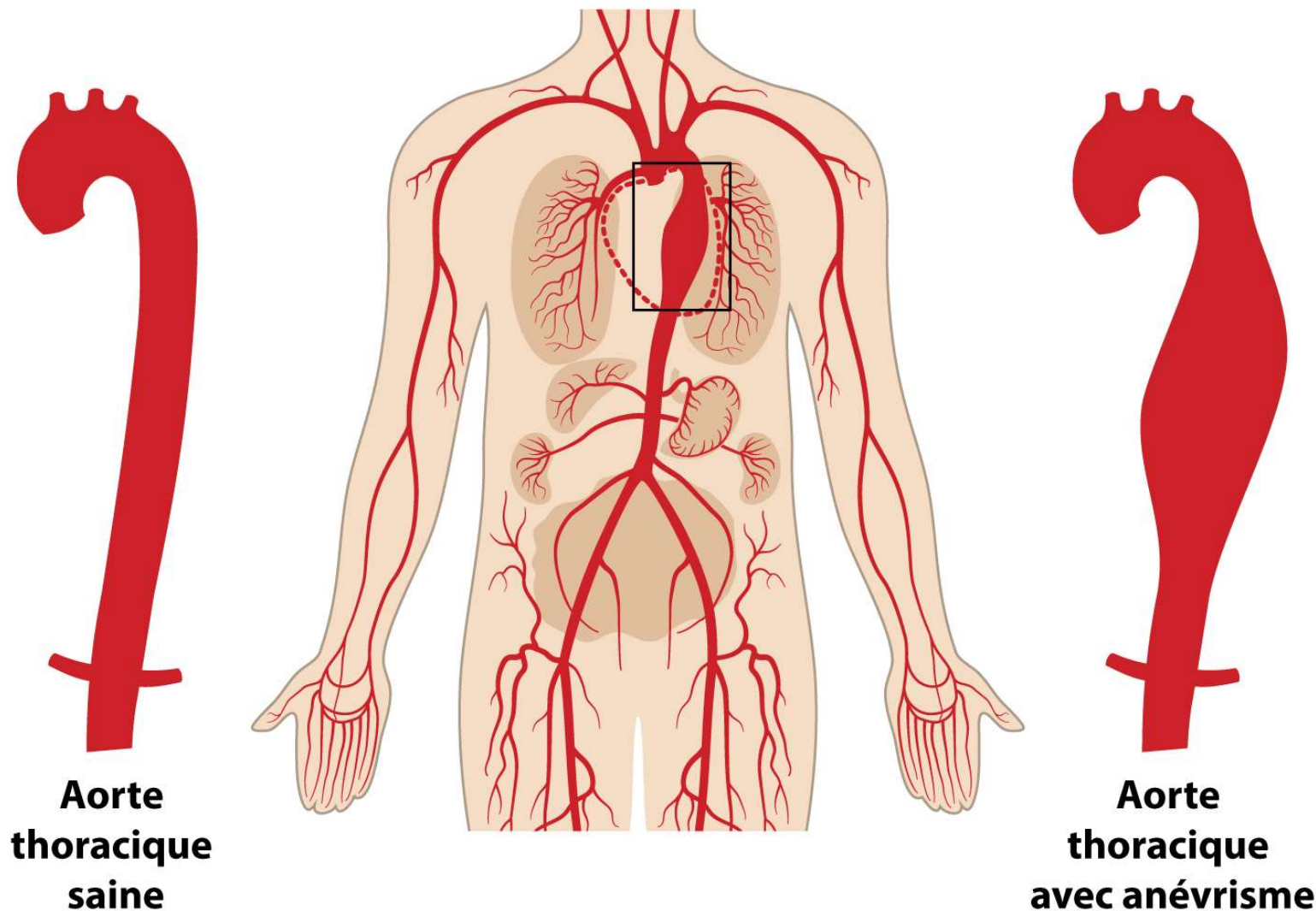
Dilatation pathologique de l'aorte à ses différents segments dont l'abdominal surtout

Facteurs favorisants : age, sexe, tabagisme, ATCD familiaux

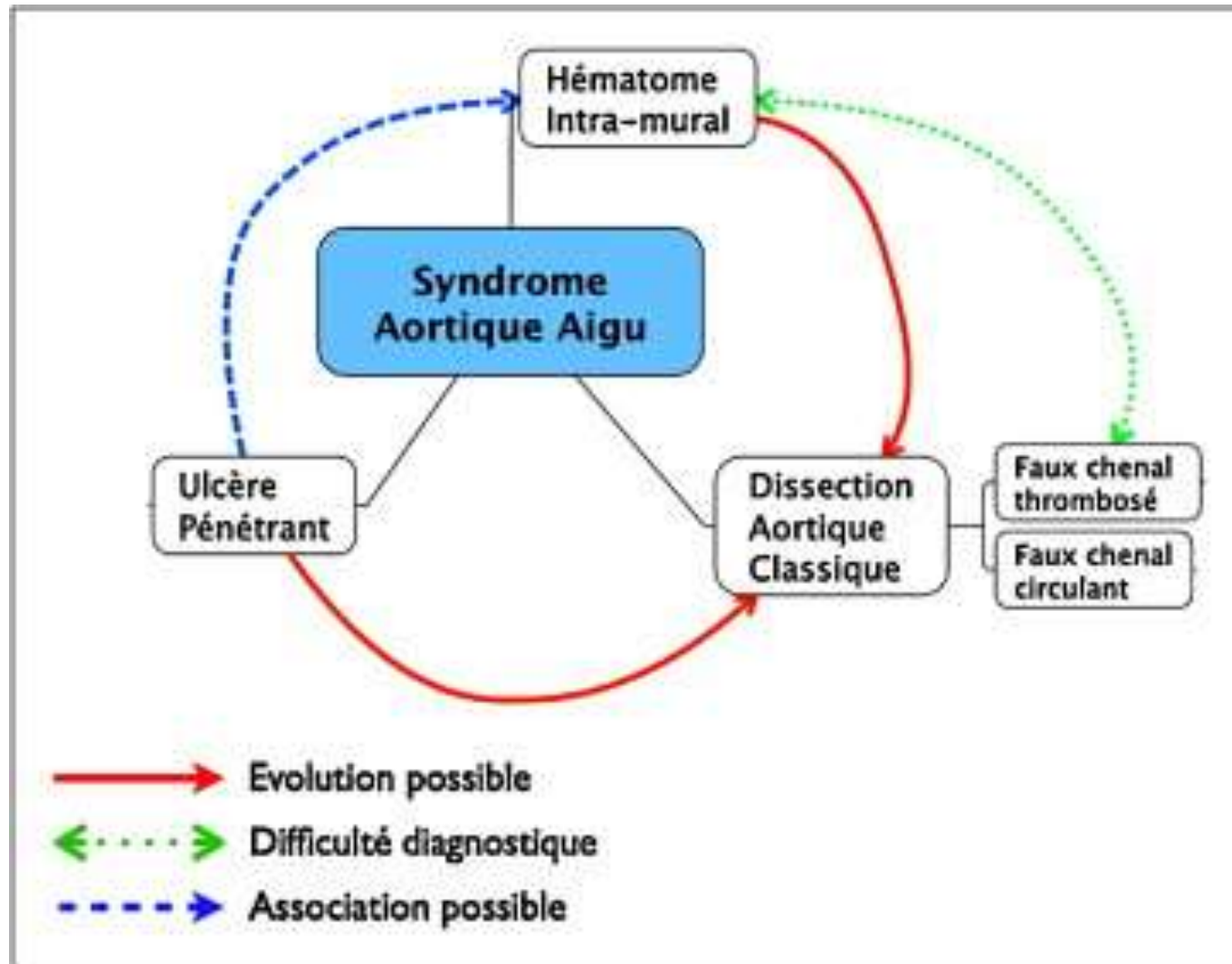
De découverte fortuite ou lors de complications

Complication fréquente et redoutable: rupture

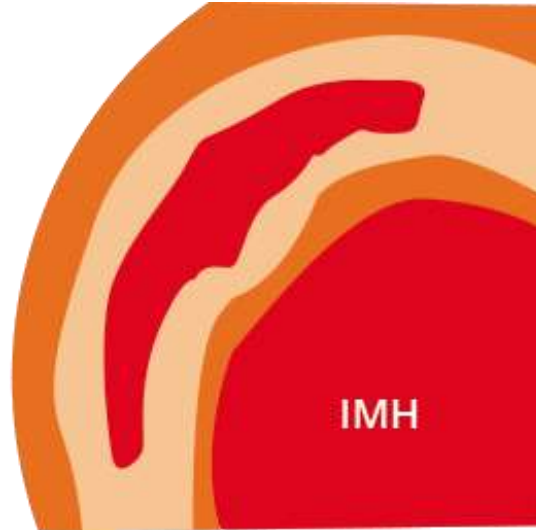
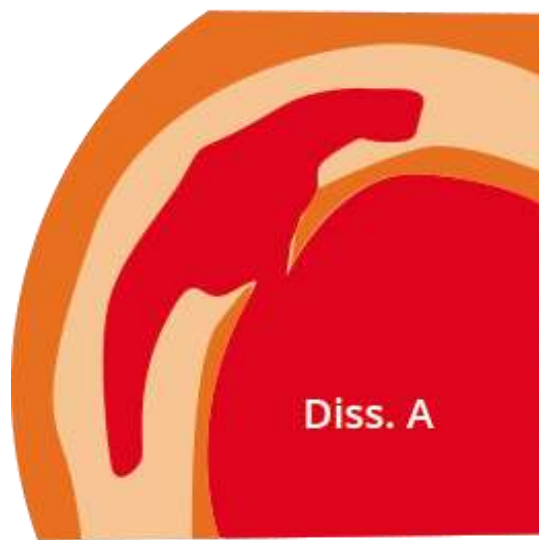
Anévrisme de l'aorte thoracique



Syndromes aortiques aigus SAA



Types de SAA



La dissection de l'aorte :

Urgence cardiovasculaire avec présentation clinique souvent dramatique

Pour la dissection de l'aorte ascendante, 1% de mortalité par heure en l'absence de chirurgie pendant les 24 premières heures, 70% de mortalité à 1 mois

- Urgence **diagnostique et thérapeutique**

I. Définition

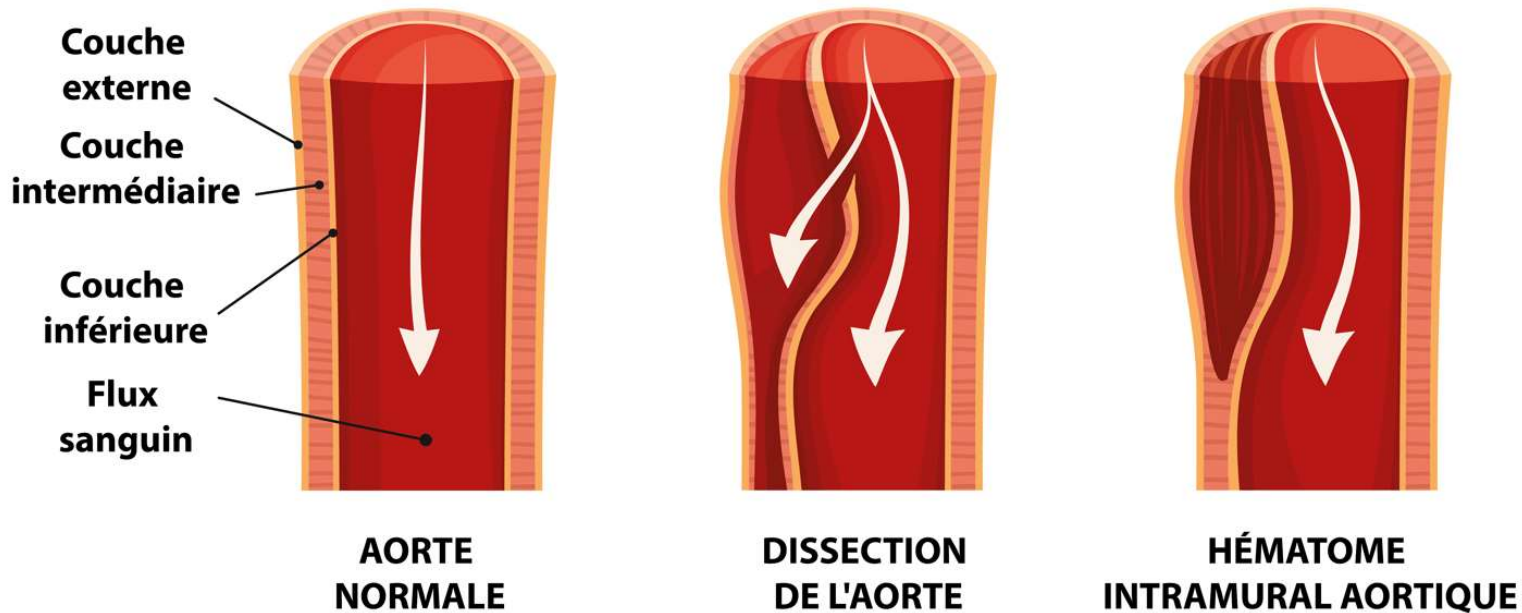
Clivage longitudinal de la média par un hématome disséquant consécutif ou non à une déchirure intimo-médiale (porte d'entrée).

Plan de clivage entre couches interne et externe de la média qui se propage plus ou moins.

Le plus souvent, existence d'un orifice de sortie (ou réentrée).

- Parfois, insuffisance aortique par dilatation de l'anneau ou décrochage d'une sigmoïde aortique.

Dissection aortique et hématome intramural aortique



II- Classification anatomique

1°) Classification de De Bakey

Type I : aorte ascendante + crosse + aorte descendante

Type II : aorte ascendante $\pm$ crosse

Type III : aorte descendante

2°) Classification de Stanford+++

Type A : aorte ascendante

Type B : ne touche pas aorte ascendante

CENTRE AORTE

Stanford

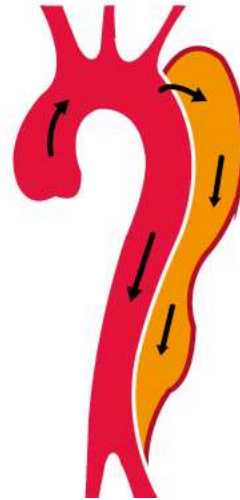
Type A



Type A



Type B



Dissections classiques



De Bakey I



De Bakey II



De Bakey III

Stanford A

Stanford B

STANFORD

DEBAKEY

Type A

Type I

Type II

Type B

Type III



NORMAL



III- Physiopathologie

- Rupture intimale → dissection
- Rupture vasa-vasorum → hématome disséquant → brèche intimale

On distingue les dissections aiguës (moins de 2 semaines) et les dissections chroniques.

IV- Etiologies:

2 grands axes étiologiques :

- **Anomalie du tissu élastique aortique :**

- Maladie de Marfan, maladie d'Elher Danlhos
- Maladie annulo-ectasiente, bicuspidie aortique, coarctation aortique

Habituellement, dissection touchant l'aorte ascendante

- **HTA et athérome: 70% des cas**

- la dissection survient dans un contexte d'HTA sévère
- patient athéromateux relativement âgé, avec d'autres localisations de la maladie athéroscléreuse
- forme localisée à l'aorte descendante ici plus fréquente

- Autres étiologies

- Traumatisme thoracique

- Iatrogène (cathétérisme...)

- Grossesse = facteur favorisant en présence d'une aorte pathologique (maladie de Marfan)

V- Diagnostic positif

A/ Tableau clinique

1°) Forme typique

- Douleur thoracique **brutale, intense**, classiquement initialement médiosthoracique, volontiers postérieure, inter-scapulo-vertébrale, **migratrice** (cou, abdomen, bras)
- Eventuellement associées à un **état de choc** ou à une augmentation de la PA = **urgence hypertensive**

Cette douleur thoracique , en particulier dans un contexte de maladie de Marfan ou chez un hypertendu , doit faire rechercher :

- une asymétrie des pouls: diminution ou abolition d'un ou des 2 pouls des membres inférieurs ou des membres supérieurs (10 à 20% des cas), parfois souffle artériel
- un souffle d'insuffisance aortique
- des signes neurologiques (10 % environ des cas)

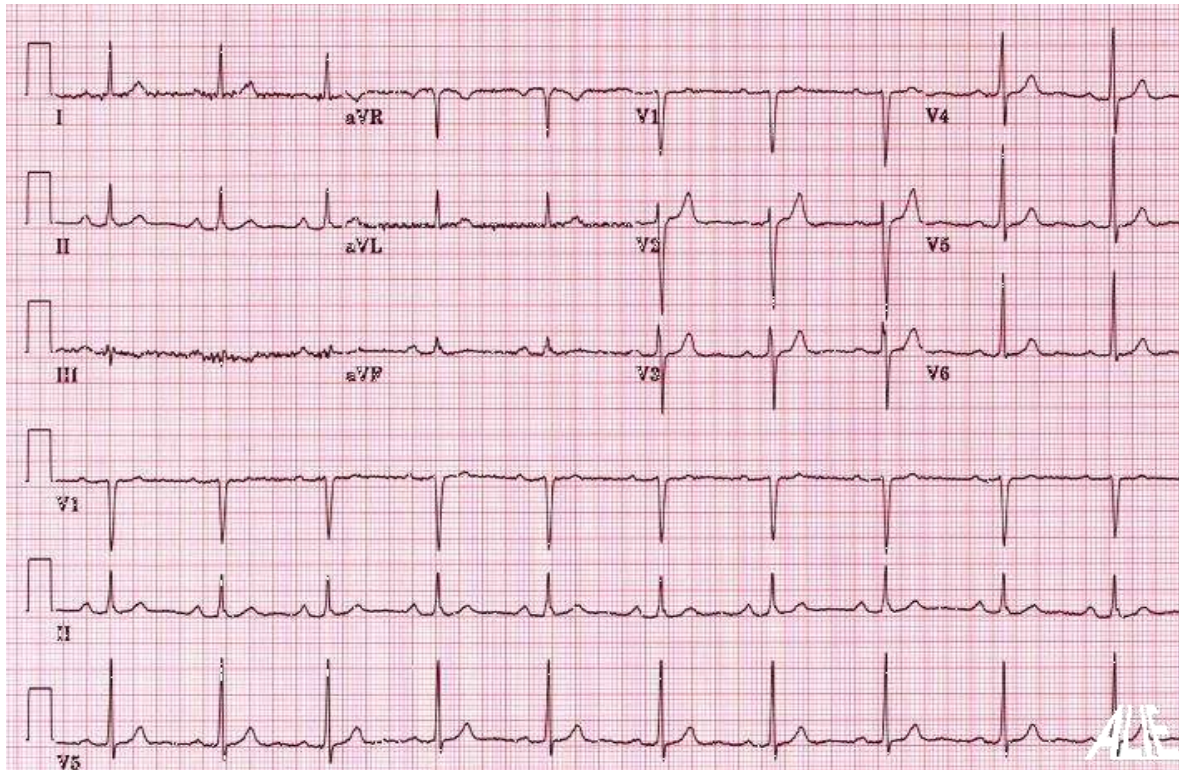
2°) Formes trompeuses

- non douloureuses (15% des cas et descendante ++++)
- douleurs extra-thoraciques: tableau abdominal pseudo-chirurgical, douleur type colique néphétique...
- collapsus secondaire à un hémothorax, un hémopéricarde, un hémomédiastin, voire à un hémopéritoine
- forme neurologique, secondaire à la propagation de la dissection au tronc vasculaire supra-aortique ou aux artères intercostales (monoplégie, paraplégie ou hémip légie)
- perte de connaissance, troubles de la conscience, voire coma

B) Examens complémentaires

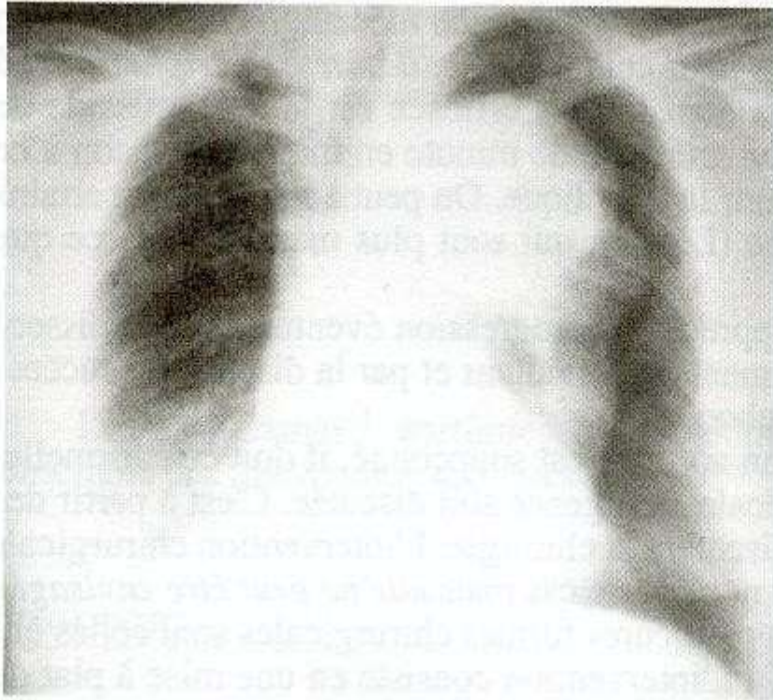
1°) ECG, thorax

- **ECG** : variable, normal, Tachycardie, HVG (HTA), IDM... (dissection touchant les artères coronaires)



- **Thorax :**

- Elargissement du médiastin +++++
- Epanchement pleural (hémothorax)



2°) Examens à visée diagnostique

Suspicion de dissection aortique → réaliser en urgence un des examens complémentaires suivants :

a Echo transthoracique et transoesophagienne

- Effectuées au lit du malade, en première intention
- Donne certitude diagnostic (**ETO ++++**) dans plus de 90% des cas : mise en évidence du voile intimal séparant vrai et faux chenal quand c'est l'aorte ascendante ++
- Précise topographie et extension de dissection, la ou les porte(s) d'entrée
- Recherche des complications : IA, hémopéricarde..

b- L'angioscanner thoracique +++

Visualise les 2 chenaux avec le voile intimal et précise l'extension de la dissection

c- L'angiographie aortique

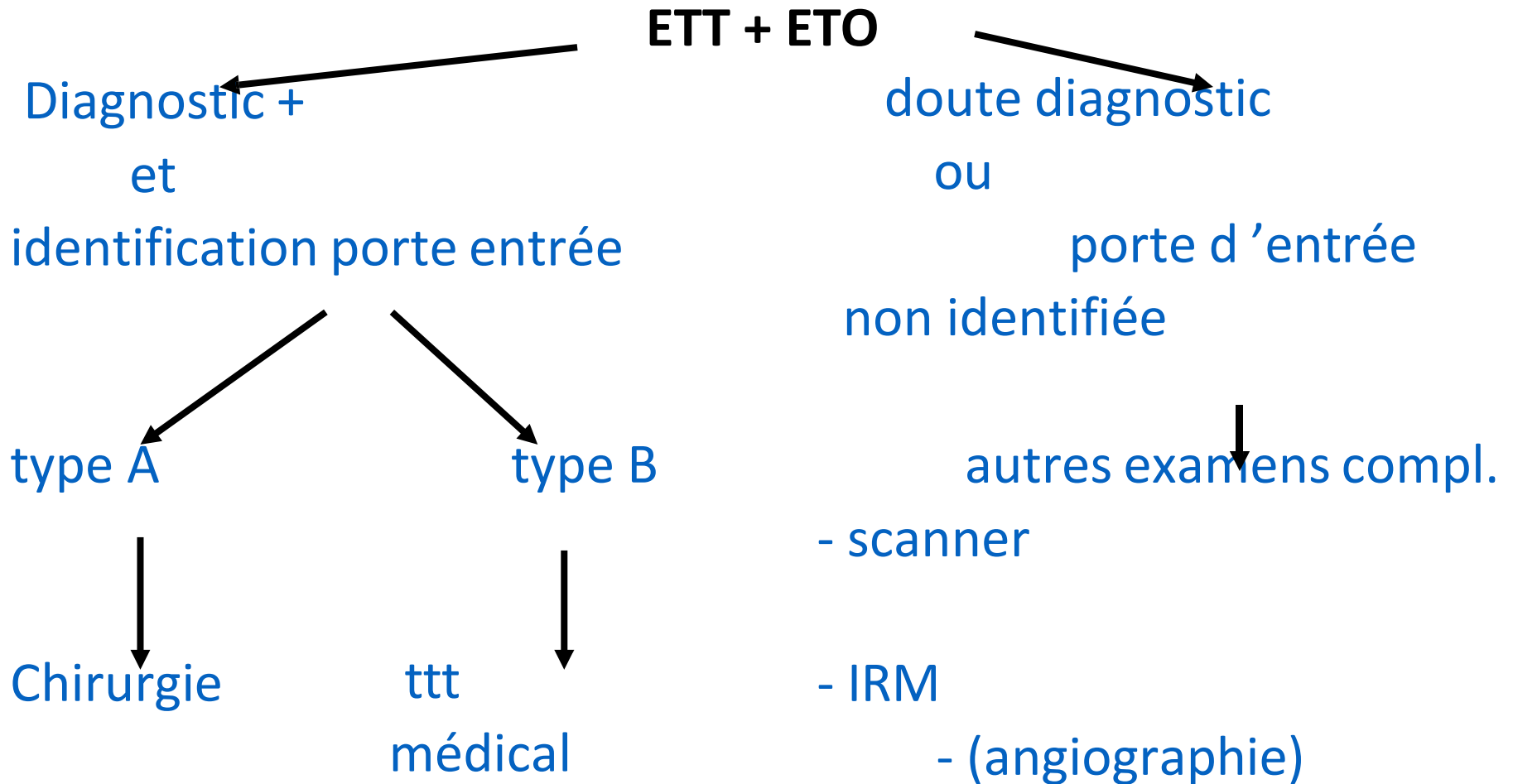
- Abandonnée

d- IRM (difficile à effectuer en urgence)

Intérêt actuellement +++ dans les dissections chroniques en raison des conditions de l'examen (malade isolé) et des difficultés d'obtention en urgence

C- Stratégie diagnostique

suspicion dissection aiguë



VI. Diagnostic différentiel

- IDM (ECG)**
- Embolie pulmonaire, péricardite
- Pathologie thoracique : pneumothorax, pleurésie
- Tamponnade peut compliquer dissection

VII. Complications

1°) Phase aiguë

- Rupture → décès
 - . Péricarde
 - . Médiastin
 - . Plèvre
- Insuffisance aortique → défaillance cardiaque gauche
- Occlusion collatérales de l'aorte (rénale, carotides, membres inf...) = ischémie aigu

2°) *Chronique*

- Dilatation de l'aorte → anévrisme (rupture, thrombose)
- Reprise dissection
- Dissection dans un autre territoire

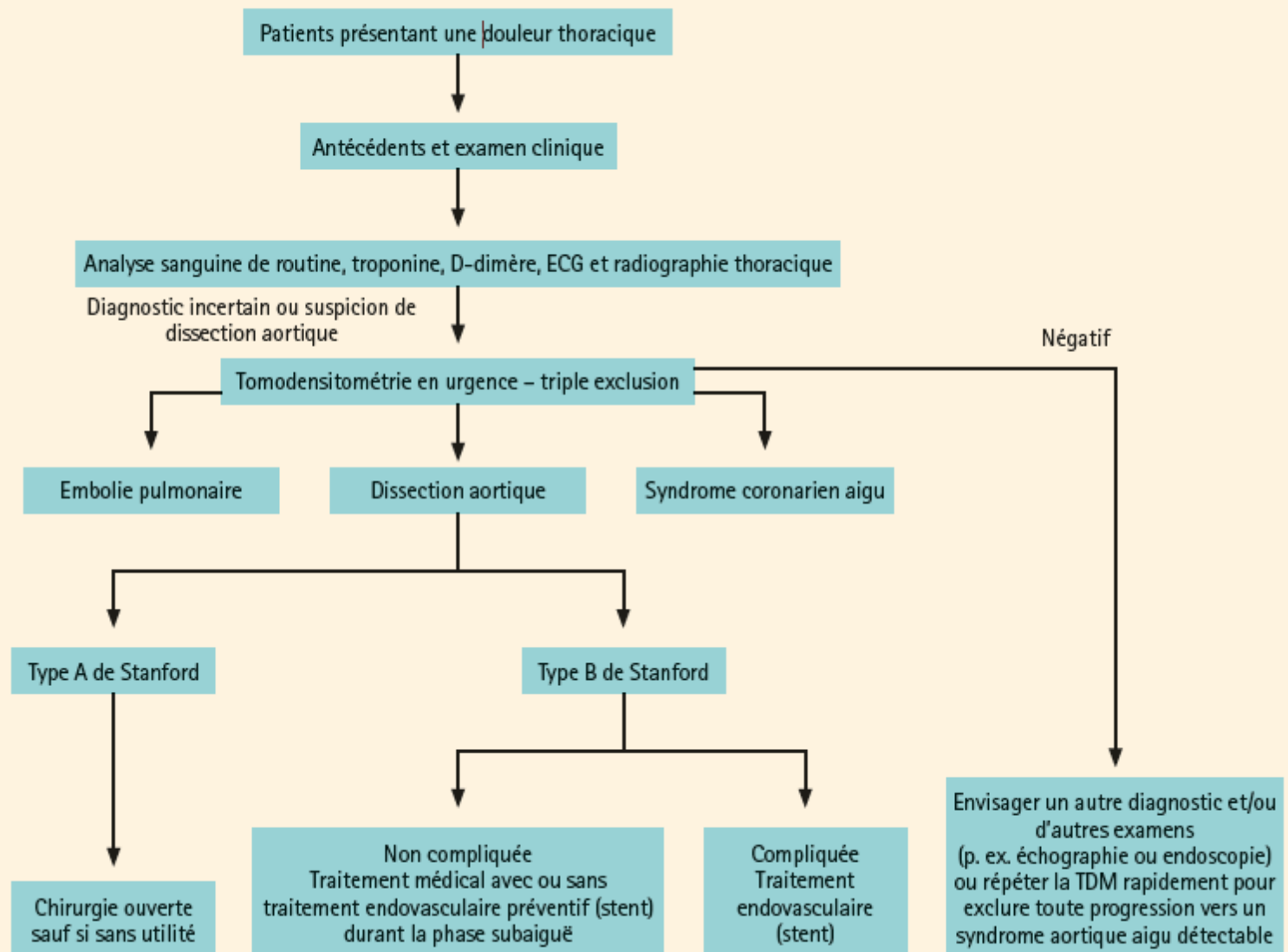
La dissection aortique

- ***maladie à vie***
- ***nécessite une surveillance***
(scanner+++, IRM+++, ETO+)

VIII. Conduite thérapeutique

- *Toute suspicion de dissection aortique aiguë conduit à une hospitalisation en USIC et à la réalisation en urgence d'un ou plusieurs examens complémentaires.*
- *Devant toute dissection proximale (A), le traitement chirurgical est envisagé en extrême urgence en raison du risque de décès.*

Figure 1. Algorithme pour l'identification et le traitement de la dissection aortique chez les patients présentant une douleur thoracique



1°) Traitement médical initial

- pas d'anticoagulant +++
- repos +++
- calmer la douleur par antalgique (morphinique)
- baisser la pression artérielle de façon rapide et efficace
 - bêtabloquants et inhibiteurs calciques en IV
 - but : maintenir PAS $\leq$ 120 mmHg et FC inf à 60batt/min

2°) Traitement chirurgical

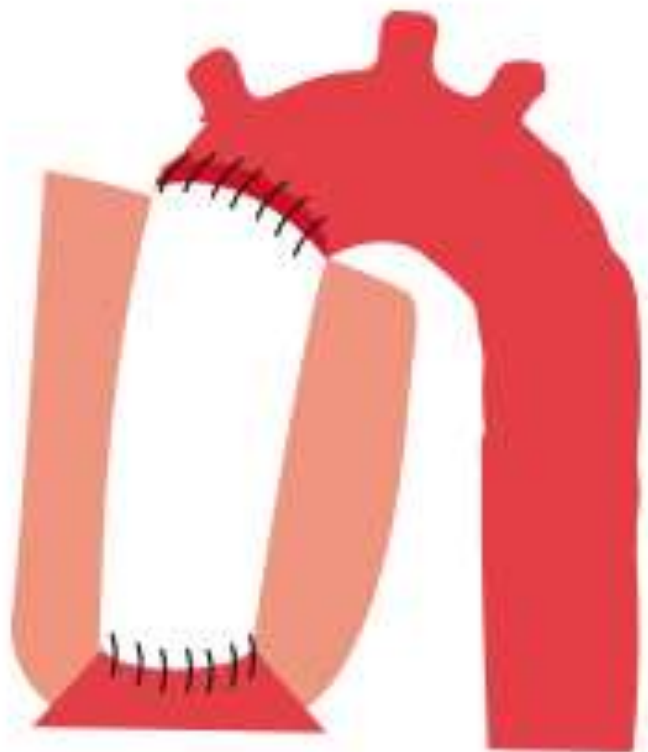
- Type A : chirurgie en urgence

le plus souvent remplacement de l'aorte ascendante par une prothèse sous CEC associée si nécessaire à un remplacement valvulaire aortique

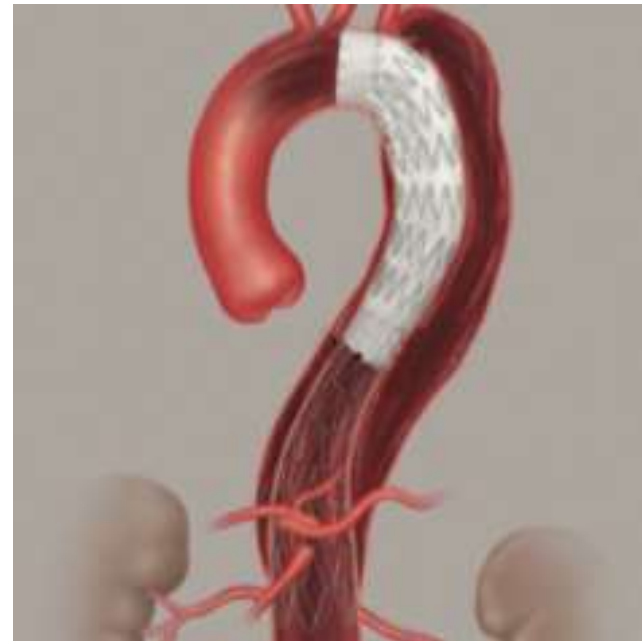
- Type B : habituellement surveillance médicale, trt interventionnel ou

chirurgie indiqués dans les formes compliquées:

- ischémie mésentérique, des membres inf...
- syndrome de fissuration



Remplacement chirurgical de l'aorte ascendante



Stenting de l'aorte crosse et descendante (endoprothèse)

3°) Traitement médical au long cours

La dissection est une *maladie de toute la vie*.

- Surveillance régulière (IRM ou scanner)
- Traitement médical par bêtabloquant si maladie de Marfan même si patient normotendu et même après chirurgie

4°) Traitement préventif

- Traitement de toute HTA
- En cas de maladie du tissu élastique touchant l'aorte ascendante : bétabloquant et chirurgie de remplacement de l'aorte ascendante prophylactique en présence d'une dilatation anévrysmale de l'Ao ascendante.

IX. Points forts

- Urgences diagnostique et thérapeutique quand la dissection touche l'aorte ascendante = chirurgie urgente
- Intérêt +++ ETO et angioscanner pour le diagnostic à la phase aiguë (IRM plutôt pour surveillance)